BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH HBsAg

Mã hiệu: **VS.MD.02.03** - Bản số: 01

Ngày hiệu lực : 16/05/2024

BVĐK ĐỨ
PHÒNG QUẢN LÝ
ĐÃ KIỂM

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
3	Cảnh báo an toàn	Thay đổi thứ tự
4	Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
5	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh HBsAg.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch T: vạch thử

5. NGUYÊN LÝ

- Bệnh viêm gan do virus là căn bệnh chủ yếu liên quan đến gan. Hầu hết các trường hợp cấp tính của bệnh viêm gan do virus là do các virus viêm gan A, viêm gan B (HBV) hoặc viêm gan C gây ra. Kháng nguyên tìm thấy trên bề mặt của HBV gọi là HBsAg.
- Kit thử HBsAg là dụng cụ xét nghiệm nhanh định tính, pha rắn để phát hiện sự có mặt của HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương. Kit thử này sử dụng hóa hợp của các kháng thể đơn dòng và đa dòng vô tính để phát hiện một cách có chọn lọc nồng độ lên cao của HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương.
- HBsAg, nếu có trong mẫu bệnh phẩm, sẽ phản ứng cộng hợp kháng thể chuột kháng HBsAg tại vùng cộng hợp của test thử. Hỗn hợp tạo thành tiếp tục di chuyển hướng lên, gặp và phản ứng kết tủa màu với kháng thể chuột kháng HBsAg tại vùng kết quả làm xuất hiện vạch màu đỏ tại vị trí vạch (T).

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Máy ly tâm, bô can.
- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay.

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử test nhanh HBsAg.
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu được lấy vào ống nghiệm không có chất chống đông hoặc có chứa chất chống đông.

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- HBsAg test nhanh có vạch (T) và cạch (C) trên bề mặt. Cả 2 vạch này đều không nhìn thấy trong cửa cổ kết quả trước khi nhỏ mẫu. Vạch chứng luôn xuất hiện nếu quy trình thực hiện đúng và thuốc thử hoạt động tốt.
- Nếu vạch (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo đúng hướng dẫn sử dụng hoặc kit thử bị hỏng do hết hạn sử dụng. Tiến hành lại với thanh thử khác.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng
KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	Lấy test ra khỏi vỏ bao và đặt trên bề mặt phẳng, ghi tên, tuổi, mã bệnh nhân lên đầu thanh test để tránh nhầm lẫn giữa các bệnh nhân
KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Dùng pipet nhựa trong kit thử, nhỏ 3 giọt (120µl) huyết thanh bệnh nhân vào giếng thử của test - Đọc kết quả sau 15 phút (đọc kết quả sau khi vạch (C) xuất hiện). Không đọc kết quả sau 20 phút
KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa	Trả kết quả	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch (C). Vạch chứng (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận
- Diễn dải kết quả:
- Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí (C)
- Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch chứng (C) và vạch thử (T)
- Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc xuất hiện một vạch (T).
- Kết quả xét nghiệm được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả)
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn sử dụng test nhanh HBsAg

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM HBsAg

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Ly tâm mẫu lấy huyết thanh		
3	Kiểm tra hạn sử dụng và tính toàn vẹn của test		
4	Ghi thông tin nhận diện bệnh nhân lên test		
5	Nhỏ 3 giọt (120µl) huyết thanh bệnh nhân vào giếng nhận mẫu của test		
6	Đọc kết quả sau 15 phút		
7	Trả kết quả trên hệ thống LIS		
Tổng điểm			